常見健康與疾病迷思解答手冊

七大重點衛教項目 · 70項迷思全破解

彰化基督教醫院 內分泌醫療團隊 製作

1 糖尿病常見迷思破解

90%+	<70 mg/dL	HbA1c
早期無明顯症狀	低血糖處置標準	長期血糖控管指標

迷思 1：吃太甜才會得糖尿病？
真相：甜食吃多會增加肥胖風險，間接增加第 2 型糖尿病風險，但主因為遺傳、體重過重、缺乏運動及胰島素阻抗，非單純因為「吃甜食」。

迷思 2：得了糖尿病就完全不能吃甜食或水果？
真相：可以吃，但需計入每日總碳水化合物（醣類）份量，並建議選擇低 GI（升糖指數）的水果與適量攝取。

迷思 3：吃降血糖藥物或打胰島素會導致洗腎？
真相：導致洗腎的主因是「長期血糖控制不良」傷害腎臟血管。適時使用降血糖藥物或胰島素能保護腎臟功能。

迷思 4：糖尿病藥物一吃就要吃一輩子？
真相：若透過飲食調整、體重控制與規律運動使血糖恢復穩定正常，醫師會評估逐步減少藥物劑量甚至停藥。

迷思 5：沒有身體不適就代表血糖控制得很好？
真相：早期或輕度高血糖通常沒有明顯症狀，等到出現「三多一少」時病情常已較嚴重，需定期量測血糖與檢驗。

迷思 6：主食改吃地瓜、南瓜或燕麥就不會升高血糖？
真相：地瓜、南瓜、燕麥均屬於澱粉類（全穀雜糧），雖然富含膳食纖維，過量攝取一樣會造成血糖大幅波動。

迷思 7：血糖偏高只要靠多運動和少吃就好，不用吃藥？
真相：生活型態調整是基礎，但若血糖已達診斷標準，仍需搭配醫師開立之藥物才能有效達到控制目標。

迷思 8：打了胰島素代表糖尿病已進入末期、沒救了？
真相：胰島素是人體自有的重要荷爾蒙，早期補充適量胰島素能讓胰臟β細胞獲得休息，更有利於長期控制。

迷思 9：空腹血糖數值正常就代表絕對沒有糖尿病？
真相：部分早期糖尿病患者空腹血糖正常，但「飯後血糖」已超標，檢驗糖化血色素（HbA1c）能更準確評估。

迷思 10：發生低血糖時只要隨便補充食物或巧克力即可？
真相：發生低血糖（血糖 < 70 mg/dL）應優先補充 15 公克「快速吸收糖類」（如方糖或果汁），高脂肪巧克力會延緩糖份吸收。

2 健康減重常見迷思破解

迷思 1：減重只要少吃多運動就一定會成功？
真相：減重受基因、荷爾蒙、睡眠與壓力等多重因素影響，單純極端少吃易導致基礎代謝率下降，引發連鎖復胖。

迷思 2：完全不吃澱粉（碳水化合物）減重速度最快最好？
真相：完全去澱粉初期減去的主要是水分與肌肉，易造成情緒低下與快速復胖，應選擇優質未精製全穀雜糧。

迷思 3：減重期間三餐只吃水果既健康又有效？
真相：水果含有豐富果糖，過量攝取易在肝臟轉化為脂肪累積，進而引發脂肪肝與體脂肪上升。

迷思 4：運動時汗流得越多，代表脂肪燃燒得越多？
真相：流汗是身體調節體溫的排汗機制，減掉的是水分而非脂肪，補充水分後體重即恢復。

迷思 5：持之以恆的運動能把脂肪直接轉化為肌肉？
真相：脂肪與肌肉是完全不同的生理組織，無法互相轉化；運動能減少脂肪體積並刺激肌肉合成成長。

迷思 6：減重期間絕對不能吃宵夜？
真相：關鍵在於「全天總熱量」與「食物種類」，若選擇低熱量、高蛋白質食物並控管總熱量，吃宵夜並不影響減重。

迷思 7：喝減肥茶或吃減肥藥可以輕鬆減重？
真相：未經醫囑的產品多含瀉劑或利尿劑，減去的是腸道廢物與水分，停用易復胖且可能損害肝腎機能。

迷思 8：進行局部運動（如仰臥起坐）可以單獨減掉特定部位脂肪？
真相：脂肪消耗是全身性的，無法指定部位燃燒脂肪。局部訓練能強化該部位肌肉線條，但無法單獨消脂。

迷思 9：吃脂肪就會長脂肪，減重必須實施完全無油飲食？
真相：適量好油（如橄欖油、堅果）對荷爾蒙合成至關重要，完全無油容易影響代謝、皮膚與腸道健康。

迷思 10：只要體重計上的數字下降就代表減重成功？
真相：減重重點是「降低體脂肪率」與「維持肌肉量」，若因極端節食導致肌肉流失，基礎代謝將會下降。

3 骨質疏鬆常見迷思破解

迷思 1：骨質疏鬆症平時會引起明顯的骨頭痠痛？
真相：骨質疏鬆症多數無明顯症狀，常被稱為「沉默殺手」，多數人直到發生跌倒骨折時才感到劇痛。

迷思 2：多喝大骨湯可以補充豐富鈣質、預防骨質疏鬆？
真相：大骨湯溶出的鈣質極少，一碗鈣含量微乎其微。補鈣應優先選擇乳製品、豆製品與深綠色蔬菜。

迷思 3：年紀大體重減輕、變矮或駝背是自然老化現象？
真相：身高比年輕時矮 4 公分以上或顯著駝背，常是脊椎壓迫性骨折的徵兆，應儘速評估骨密度。

迷思 4：骨質疏鬆症是女性專利，男性不會得到？
真相：年長男性也會因男性荷爾蒙下降、吸菸、過量飲酒或長期使用類固醇而患上骨質疏鬆症。

迷思 5：補充鈣片就足夠預防骨質疏鬆？
真相：單補充鈣質若缺乏維生素 D（促進鈣吸收）與負重運動（刺激骨骼形成），鈣質難以有效沉積於骨骼。

4 肌少症常見迷思破解

迷思 1：肌少症只發生在體型消瘦的人身上，胖子不會有？
真相：肥胖者同樣會患有肌少症（稱為「肌少性肥胖」），雖然體重偏重，但肌肉質量不足且脂肪過高。

迷思 2：年紀大了肌肉減少是自然現象，無法透過訓練改善？
真相：雖然隨年齡增長肌肉會流失，但透過充足蛋白質補充與規律阻力訓練（重訓），長者一樣能增加肌肉量。

迷思 3：每天多走路、散步或慢跑就可以預防肌少症？
真相：散步慢跑主要訓練心肺耐力，對增加肌肉量效果有限；預防肌少症需進行「阻力運動」（如彈力帶、深蹲）。

迷思 4：長者為了養生清淡飲食，應該多吃素或少吃肉？
真相：長者若蛋白質攝取不足會加速肌肉流失。應確保每餐攝取足量優質蛋白質（蛋、豆、魚、肉）。

迷思 5：只要補足蛋白質，不需要運動也能增長肌肉？
真相：蛋白質是原料，但必須配合阻力運動給予肌肉適度刺激，才能有效啟動肌肉蛋白質合成機制。

5 代謝症候群常見迷思

迷思 1：代謝症候群沒有不適感，不需特別處理？
真相：代謝症候群是糖尿病與心血管疾病的警訊，若不加以控制，演變為慢性病的風險將增加數倍。

迷思 2：量體重就知道有沒有代謝症候群？
真相：關鍵指標為「腰圍」（男≥90cm，女≥80cm，反映內臟脂肪），體重正常但腰圍超標者同樣高危險。

迷思 3：代謝症候群是不可逆的健康問題？
真相：透過減重 5~10%、規律運動與均衡飲食，各項指標（血糖、血壓、血脂、腰圍）均有極高機會恢復正常。

6 糖尿病與牙周病關係迷思

迷思 1：糖尿病與牙周病是兩種完全無關的疾病？
真相：兩者具雙向影響關係：糖尿病會增加牙周病風險；而嚴重的牙周病發炎反應也會使血糖控制更為困難。

迷思 2：只要血糖控制好，牙周病就會自動痊癒？
真相：控制血糖能減少發炎，但已形成的牙結石與牙周囊袋必須由牙醫師進行專業口腔治療才能根除。

迷思 3：每天按時刷牙就不會罹患牙周病？
真相：刷牙無法完全清除牙縫死角，需搭配牙線或牙間刷；且糖尿病患者免疫較弱，需定期進行牙科檢查。

7 甲狀腺疾病常見迷思

迷思 1：甲狀腺腫大（俗稱大脖子）就一定是甲狀腺亢進？
真相：腫大可能是亢进、低下、結節或甲狀腺炎引起，需透過血液抽檢與超音波檢查確認診斷。

迷思 2：甲狀腺檢查發現有結節就代表罹患癌症？
真相：臨床上超過 90% 以上的甲狀腺結節均為良性，僅有極少數為惡性腫瘤，不必過度恐慌。

迷思 3：得了甲狀腺疾病就絕對不能吃含碘食物（如海帶）？
真相：需視類型而定：自體免疫引起的亢進需限制碘；但若是缺碘引起的低下，則需適量補充碘。

🏥 **衛教諮詢提醒：如有任何健康疑問或用藥問題，請諮詢彰基內分泌醫療團隊**